



Programme National d'Immunisation

Vaccination de rattrapage

Recommandations 2023



Vaccination de rattrapage

- L'action de vacciner un individu qui, pour une raison quelconque (Maladie, négligence, accès au service, réticence, rupture de stock...) n'a pas reçu/a manqué les doses de vaccins auxquelles il peut prétendre, conformément au calendrier national de vaccination.
- Une vaccination de rattrapage doit être établie quelques soit les raisons du retard
- Impact majeur sur la réduction des disparités en matière de vaccination et sur la morbidité et la mortalité.

Calendrier national de vaccination 2023

[illegible]

Calendrier des vaccinations

- Vaccinations recommandées à chacun et à tous (dans la population générale) en fonction de son âge.
- c'est un compromis entre le risque en fonction de l'âge et le **potentiel immunitaire** de la personne (maturation, persistance)
 - infection à pneumocoque: risque chez le nourrisson,
 - coqueluche chez le nourrisson : nécessité d'une immunisation la plus rapide possible
- Il tient compte des **caractéristiques du vaccin** (dossier d'AMM).



Principes de la vaccination de rattrapage

- Chaque enfant devrait bénéficier pleinement de la vaccination en recevant les vaccins recommandés dans le calendrier national de vaccination.
- Il est préférable de vacciner en retard que de ne pas vacciner du tout.
- L'administration simultanée de plusieurs doses de vaccin peut se faire en toute sécurité.
- Les retards entre les doses d'une série vaccinale (p. ex., Penta1, 2, 3) ne nécessitent pas la reprise de la série entière depuis le début, quelle que soit la durée écoulée depuis l'administration de la dernière dose.

Les 6 règles de rattrapage vaccinal

Règle 1 : Il est préférable de considérer qu'une personne n'est pas vaccinée plutôt que de la croire erronément protégée.

Règle 2 : Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni de recommencer toute la série de vaccins ni d'y ajouter des doses supplémentaires.

Règle 3 : La présence d'une infection mineure ou d'une fièvre de faible intensité (ne dépasse pas 38 °c) ne doit pas retarder le rattrapage vaccinal.

Les 6 règles de rattrapage vaccinal

Règle 4: Tous les vaccins peuvent être administrés le même jour

Règle 5: Utiliser des sites différents lors d'injections multiples, espacés d'au moins 2,5cm, en privilégiant les deltoïdes chez les grands enfants et la face antérolatérale de la cuisse chez les nourrissons.

Règle 6: Pour chaque enfant, on doit vérifier son statut vaccinal pour définir les doses manquantes.

Doses manquantes =

Doses recommandées (selon l'âge) - Doses reçues

C'est la bilan Vaccinal



Principe général

« Lorsque un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en réalisant le nombre d'inoculations requis en fonction de l'âge. »



Chaque cas de
rattrapage doit être
étudié selon le cas

Évaluation du statut vaccinal et détermination de l'admissibilité

UTILISATION DE LA DOCUMENTATION ÉCRITE (LE CARNET DE SANTÉ OU LE REGISTRE DE VACCINATION...)

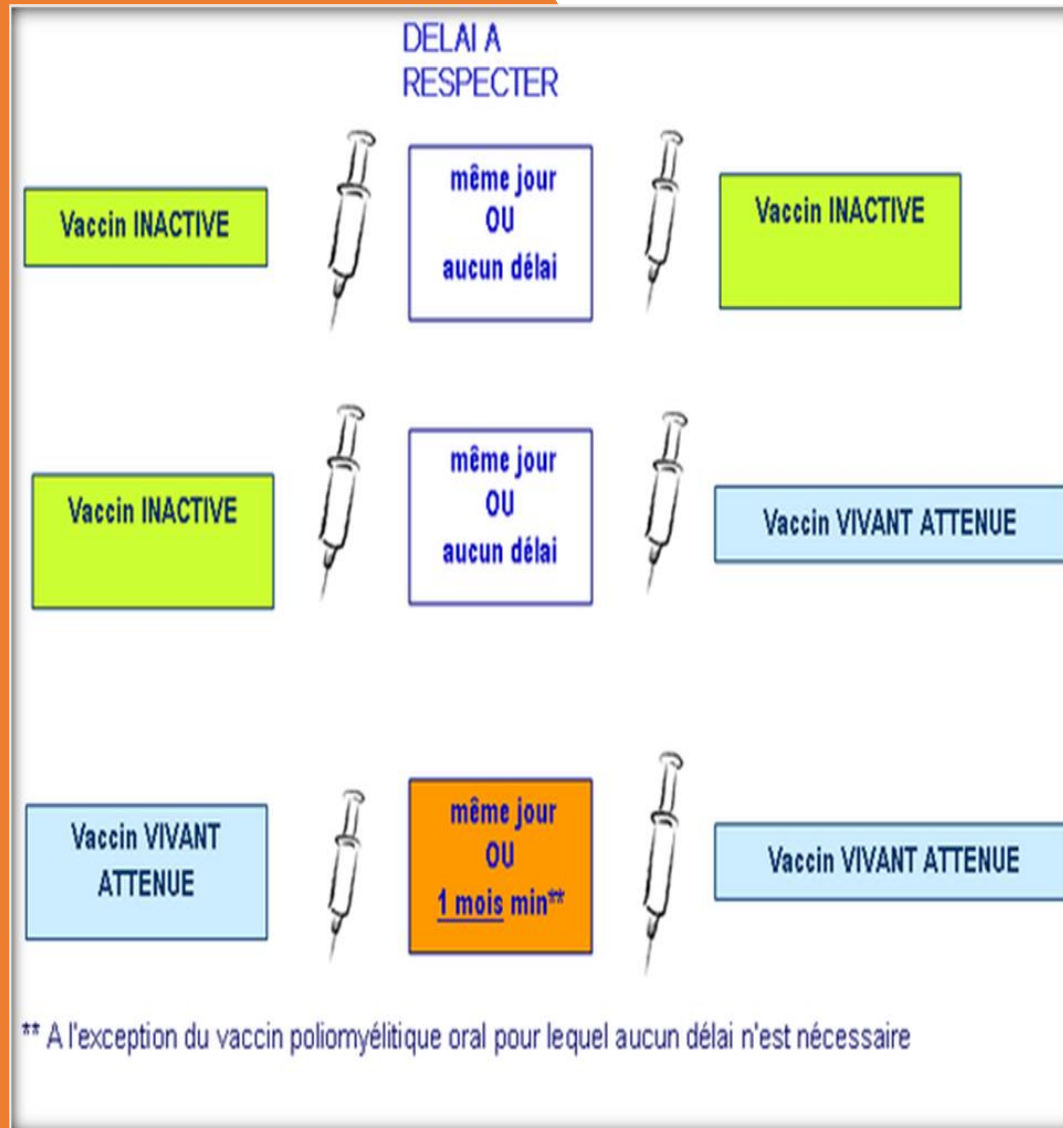
SI LA PREUVE D'UNE VACCINATION ANTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE ÉTABLIE, IL CONVIENT DE SUPPOSER QUE L'INDIVIDU N'A PAS BÉNÉFICIER DU/DES VACCIN(S) ET DE LUI PROPOSER LA VACCINATION SANS AUCUN RISQUE.

Rattrapage
vaccinal =
donner les
doses
manquantes
pour recalculer sur
le calendrier de
base

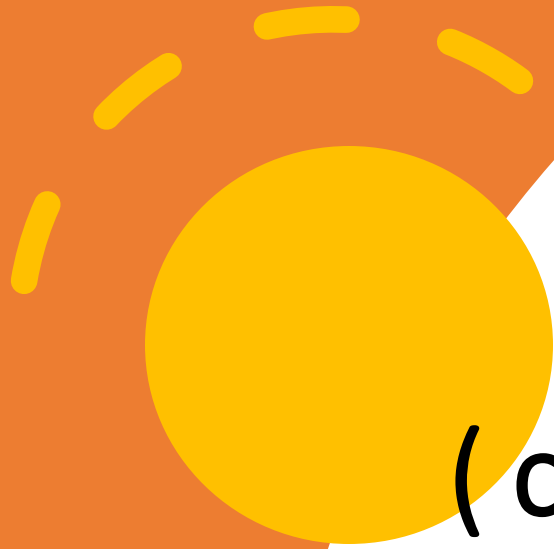
POUR CHAQUE ANTIGENE :

1. Déterminer l'âge au moment du rattrapage
2. Déterminer le nombre de doses reçues
3. Déterminer le nombre de doses nécessaires que l'enfant devrait avoir reçues si la vaccination n'avait pas été interrompue (en fonction de l'âge à la primovaccination)
4. **Calculer les doses manquantes = doses nécessaires - doses reçues.**
5. Vérifier que cela ne dépasse pas le nombre de doses d'un enfant encore jamais vacciné !
6. Choisir les intervalles / les combinaisons vaccinales appropriées.

Délai entre l'administration de vaccins inactivés et de vaccins vivants



Vaccins vivants atténués (VVA)	Bactéries : Vaccin BCG ← Virus : - Vaccin de l'encéphalite japonaise inactivé - Vaccin antipoliomyélitique oral ← - Vaccin anti rougeoleux, vaccin anti ourlien ← - Vaccin anti rotavirus - Vaccin anti amaril ←
Vaccins inactivés (antigènes tués)	Bactéries : Vaccin antioquelucheux à cellules entières (Cce) Virus : - Vaccin de l'encéphalite japonaise inactivé - Vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) ←
Vaccins sous-unitaires (Antigènes purifiés)	Protéiques : - Vaccin anti-hépatite B ← - Vaccin antioquelucheux acellulaire (Ca) Polysaccharidiques : - Vaccin polysaccharidique antiméningococcique - Vaccin polysaccharidique antipneumococcique - Vaccin polysaccharidique antityphoïdique Vaccin conjugué : - Vaccin anti-Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugué ← - Vaccin antiméningococcique A et B conjugué - Vaccins antipneumococciques (VPC-7, VPC-10, VPC-13) conjugués ← - Vaccin Antityphoïdique Vi conjugué.
Anatoxines	Anatoxine tétanique ← Anatoxine diphtérique ←



Recommandations (calendriers) pour la vaccination interrompue ou retardée

Important

- Si l'enfant n'est jamais vacciné : appliquez un calendrier de rattrapage selon son l'âge et complétez suivant le calendrier national.
- Si l'enfant est incomplètement vacciné ,poursuivre la vaccination suivant le calendrier correspondant à son âge et suivant les règles établies .
- Le rattrapage doit être établi suivant les vaccins disponibles.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge ≤ à 12 mois

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	6ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	15 jours après la 4ème visite	Minimum 2 mois après la 5ème visite	
BCG	1 dose						
Penta	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• Administrer 2 doses de rappel par le DTC à 18 mois et à 5 ans
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose			• 2 doses du VPO à 18 mois et à 5 ans
VPI	1 dose						
RR	1ère dose						• Ne pas administrer le RR qu'à partir de 9 mois • 2ème dose à 18 mois
Pneumo		1ère dose			2ème dose	3ème dose	• Âge < 7 mois: 4 doses de PCV 13 • Entre 7 mois et 11 mois: 3 doses avec un intervalle minimum de 2 mois entre les doses • Décaler de 15 jours par rapport au Penta
Rotavirus	1ère dose		2ème dose	3ème dose			

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge > à 1 an et ≤ à 3 ans

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	6ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	2 mois après la 2ème visite	6 mois après la 3ème visite	
BCG	1 dose						- Rechercher la cicatrice 0,1 ml en intradermique
Penta/DTC	1ère dose Penta		2ème dose DTC				1er rappel: 6 mois après la 3ème visite 2ème rappel: 4 ans après le 1er rappel
Hépatite B			1 dose			1 dose	1 dose du HB monovalent au moins 1 mois après la dose incluse dans le Penta - Une 2ème dose du HB monovalent au moins 6 mois après - Toujours comptabiliser les prises incluses dans le Penta, si l'enfant a déjà reçu des doses
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose			2 doses du VPO avec les rappels du DTC
VPI	1 dose						
RR	1ère dose		2ème dose				2ème dose à partir de 18 mois - Si l'enfant est âgé de plus de 18 mois et jamais vacciné: administrer 2 doses à 1 mois d'intervalle
Pneumo		1ère dose*			2ème dose		- Entre 12 mois et 23 mois: 2 doses avec un intervalle minimum de 2 mois * Entre 2 ans et 5 ans: 1 dose - Décaler de 15 jours par rapport au Penta
Rotavirus	1ère dose		2ème dose	3ème dose			Si le vaccin utilisé est ROTASIL l'âge limite est 24 mois

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Calendrier de rattrapage vaccinal des enfants : âge > à 3 ans et ≤ à 6 ans

Vaccins	1ère visite	2ème visite	3ème visite	4ème visite	5ème visite	Observations / Doses de rappel
		15 jours après la 1ère visite	1 mois après la 1ère visite	1 mois après la 3ème visite	6 mois après la 3ème visite	
BCG	1 dose					• Rechercher la cicatrice • 0,1 ml en intradermique
DTC	1ère dose		2ème dose		3ème dose	• Si l'enfant est âgé de 3 à 5 ans: administrer une dose rappel du DTC ou Td (selon l'âge) après 4 ans • Pas de Penta après 3 ans
Hépatite B	1ère dose		2ème dose		3ème dose	• Toujours comptabiliser les prises incluses dans le Penta, si l'enfant a déjà reçu des doses
VPO	1ère dose		2ème dose	3ème dose	4ème dose	• Administrer une dose du VPO avec le rappel du DTC/Td
VPI	1 dose					
RR	1ère dose		2ème dose			
Pneumo		1 dose				• Une seule dose si âge inférieur à 5 ans

NB: N'administrer que les doses manquantes. Une fois que l'enfant a rattrapé son retard, poursuivre l'utilisation du Calendrier National de Vaccination jusqu'à ce qu'il soit complètement vacciné.

Interchangeabilité de formulations de vaccins ou de produits de fabricants différents

- En général, les produits d'un même fabricant doivent être utilisés pour toutes les doses d'une série vaccinale. Toutefois, si une série ne peut pas être complétée avec le même vaccin, le produit de remplacement disponible devrait être utilisé.
- La reprise d'une série n'est pas recommandée, même en ce qui concerne les séries primaires.
- Les diluants de vaccins ne sont pas interchangeables entre les fabricants ni entre les formulations. Seul le diluant attribué par le fabricant pour le vaccin et la présentation spécifique doit être utilisé.

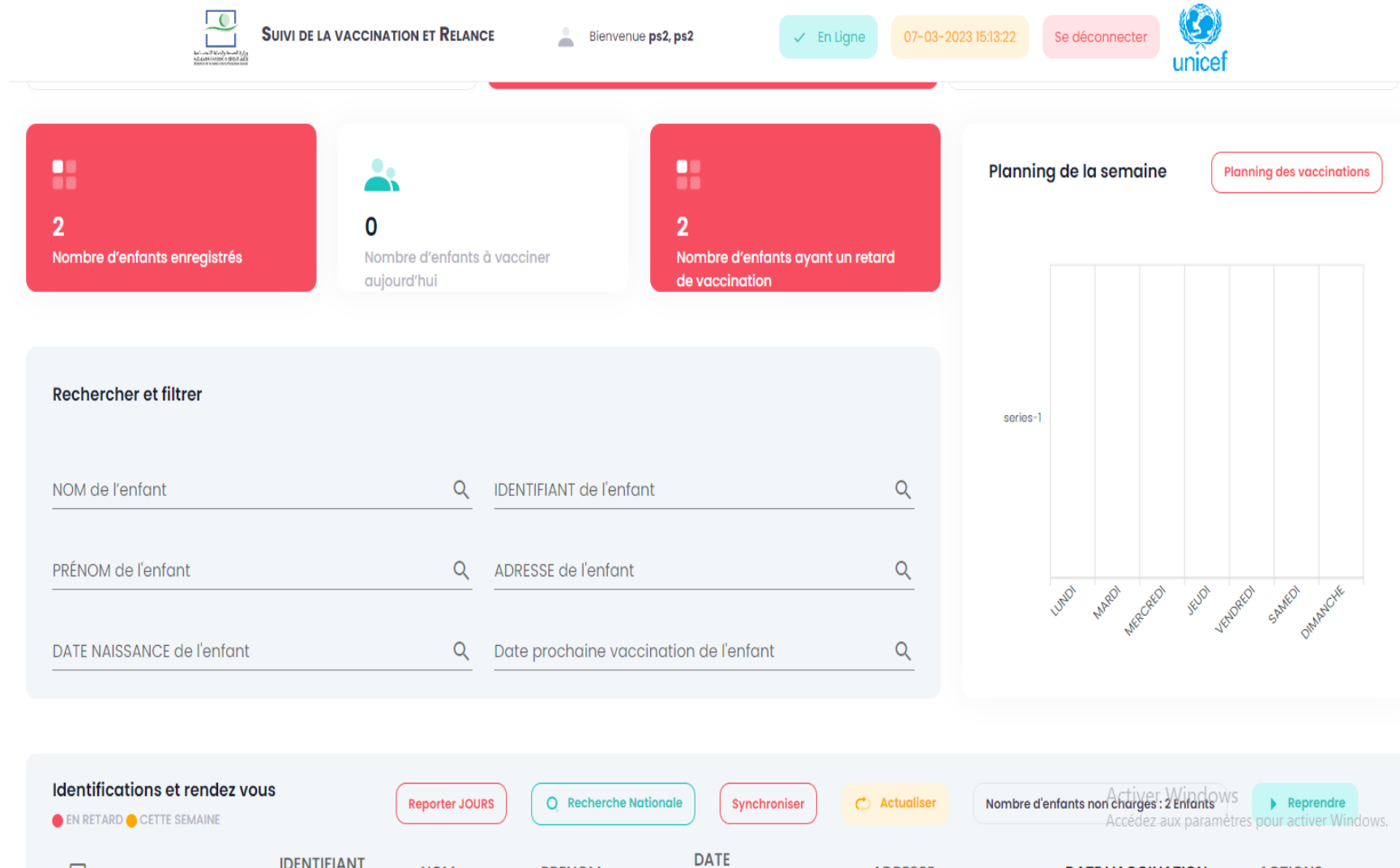


Stratégies de la vaccination de rattrapage

Stratégies pour la vaccination de rattrapage

- La vaccination de rattrapage peut se faire par le biais de :
 - La prestation régulière des services de vaccination systématique (fixe, mobile, à l'école)
 - L'intensification périodique de la vaccination systématique.
- Les activités de mobilisation sociale à l'échelle de la communauté sur les avantages de la vaccination systématique et la sensibilisation à la disponibilité des services de vaccination.
- Des stratégies locales novatrices et créatives devraient être explorées afin d'encourager les individus à revenir pour de futures vaccinations et renforcer le message **selon lequel «il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner»**.

La réduction des occasions manquées de vaccination: Elaboration d'une application informatique de suivi et de relance de la vaccination



Consignation et déclaration des doses de vaccination de rattrapage

- Les vaccins administrés en dehors de la plage d'âge cible doivent être enregistrés, déclarés et surveillés.
- Les doses de vaccins de routine, les dates auxquelles ces dernières ont été administrées et les dates de suivi pour la prochaine visite de vaccination doivent figurer sur le carnet de santé de l'enfant.
- Les registres de vaccination doivent mentionner les doses administrées au-dessus de l'âge cible.
- Les rapports doivent consigner et résumer toutes les données recueillies sur la vaccination de rattrapage.

Exemples : 2 situations

Une maman ramène son enfant âgé de 3 ans pour rattrapage vaccinal. Elle déclare que son fils est correctement vacciné selon le calendrier vaccinal officiel jusqu'à l'âge de 7 mois.

- Proposez un calendrier de rattrapage pour cet enfant

Réponse

Il faut faire le bilan vaccinal

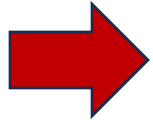
POUR CHAQUE ANTIGENE : (RR)

1. Déterminer l'âge au moment du rattrapage : **3 ans**
2. Déterminer le nombre de doses reçues : 0
3. Déterminer le nombre de doses nécessaires que l'enfant devrait avoir reçues si la vaccination n'avait pas été interrompue (en fonction de l'âge à la primovaccination) : 2
4. **Calculer les doses manquantes = doses nécessaires -doses reçues. (2-0 =2)**
5. Vérifier que cela ne dépasse pas le nombre de doses d'un enfant encore jamais vacciné !
6. Choisir les intervalles / les combinaisons vaccinales appropriées.(vaccin RR min 4 semaines)

Réponse :

Il faut compléter selon le calendrier national. Doses manquantes= (doses recommandées- doses reçues), de ce qui lui manque à son âge :

- 2 doses RR
- 1 dose pneumocoque
- 2 doses VPO
- 1 dose DTC



Après , Utilisez le calendrier de rattrapage correspondant à son âge

- 1ère visite : 3 ans → 1 dose de DTC (Rappel) + 1 dose RR (première dose) + VPO
- 2 -ème visite : 15 jours après : 1 dose du PCV 13 (WEUPHORIA)
- 3 -ème visite : 3 ans et 1 mois → 2 -ème dose RR
- 4 -ème visite : 7 ans : 2 -ème dose Td (rappel) + une dose de VPO

Hajar 22 mois a reçu à ce jour :

- BCG
- 2 Penta (DTC, Hib, HB) à 2 mois et 3 mois
- 1 Pneumo conjugué à 4 mois
- 1 RR à 9 mois
- 4 VPO
- 1 dose de VPI
- 1 dose rotavirus

Quel schéma de rattrapage vaccinal est à proposer à Hajar?

Réponse:

- BCG : elle est à jour
- 1 HB : il manque 1 dose
- 2 doses de Penta: à 22 mois elle besoin que de 2 doses de Penta (déjà reçu)donc hajar lui manque 2 doses de rappels DTC
- 4 doses de Pneumo PCV 13 : il manque aucune dose (à 22 mois: 1 dose de PCV13)
- 2 doses de vaccin RR : il manque 1 dose
- 1 VPI: elle est à jour
- 2 doses de rotavirus : il manque 1 dose
- 5 doses de VPO : il manque 1 dose

La proposition des doses de rattrapage de Hajar :

- ✓ 1ère visite (à 22 mois) :
 - ✓ 1 dose de rappel DTC
 - ✓ 1 dose HB
 - ✓ 1 dose VPO
 - ✓ 1 dose RR
 - ✓ 1 dose Rotasiil
- ✓ 2ème visite: à l'âge de 6ans et 2 mois : une dose Td + 1 dose VPO

Rattrapage vaccinal

Au total !

- ✓ Variable : du simple au complexe
- ✓ A des règles
- ✓ Nécessite une réflexion
- ✓ Cas par cas
- ✓ Faisable



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



N.Réf. :DELM/DP

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux

du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Objet : Renforcement des activités de vaccination et de surveillance du Programme National d'Immunisation.

Réf. :- Circulaire Ministérielle N°52/DP/19 du 16 Juin 2023 portant sur la situation de la couverture vaccinale de la rougeole et de la rubéole de l'année 2022.

- Circulaire N°69/DELM/28 juillet 2023 portant sur le renforcement de la surveillance des fièvres éruptives.

Il m'a été permis de constater le faible taux de couverture par le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole (RR) au titre des années 2022 et 2023, malgré les directives des Circulaires Ministérielles citées en référence. Aussi, des cas groupés de rougeole ont été rapportés. Dans certaines localités, ce qui confirme ce constat.

Il va sans dire qu'en plus du maintien d'une couverture vaccinale uniforme (par niveau et par milieu) supérieure ou égale à 95%, il devient impératif de renforcer le système de surveillance des fièvres éruptives, en vue de détecter précocement tout éventuel cas de rougeole ou de rubéole et de riposter à toute situation susceptible d'être à l'origine de la propagation de leurs virus respectifs.

A ce titre, je vous demande de veiller personnellement à :

- Assurer **en urgence** la mise en œuvre d'un plan d'activités supplémentaires de vaccination en maintenant les activités de routine à leur niveau optimal de performance.
- Réaliser des mini-campagnes de rattrapage vaccinal ciblant les enfants de 18 à 60 mois tout en vérifiant leur statut vaccinal et en visant spécifiquement la rougeole, la rubéole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.
- Veiller, dans le cadre de la Visite Médicale Systématique (VMS), d'assurer auprès des élèves de la première année scolaire, la vérification de leur statut vaccinal avec rattrapage et ce, selon les directives du Programme National d'Immunisation.
- Mettre en place un système continu de relance des enfants de moins de 18 mois ayant une vaccination retardée.
- Veiller à l'évaluation au niveau régional de la complétude des données de la vaccination sur l'application SREC pour une prise de décision rapide et efficace.
- Renforcer la surveillance épidémiologique des fièvres éruptives au niveau régional, et ce pour atteindre un taux de notification des cas de fièvres éruptives de 2 pour 100 000 habitants au niveau de chaque province/préfecture. Aussi, il est requis de mener une vérification de cette situation depuis le mois septembre 2023 afin de détecter tout cas non notifié.
- Mener une investigation épidémiologique de tout cas de fièvre éruptive, comprenant la réalisation des prélèvements, conformément aux dispositions en vigueur tel que retenu dans les procédures de surveillance des fièvres éruptives.

Ministre de la Santé
et de la Protection Sociale

Khalid AIT TALEB





24 OCT. 2023

URGENT

D/2023/DP/SMI/PSI/PNI/ 156

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux
de la Santé et de la Protection Sociale

Objet : Vérification du statut vaccinal et rattrapage vaccinal au profit des
élèves de la première année du primaire.

Réf : Circulaire N° 92 en date du 02 octobre 2023.

La campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire, lancée en octobre de cette année, constitue une occasion incontournable pour assurer la vérification du statut vaccinal et le rattrapage des élèves de la première année du primaire concernant la vaccination contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la rubéole.

A cet effet, vous trouvez ci-joint, une fiche technique précisant les objectifs et les modalités de vérification du statut vaccinal et du rattrapage vaccinal.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux, l'expression de mes salutations les meilleures.

Dr. YAHYANE Abdelhakim
Directeur de la Population



Direction de le Population
Programme National d'Immunisation
Campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de
santé de la population scolaire

Vérification du statut vaccinal au profit des élèves de la 1^{ère} année du primaire
et modalités de rattrapage

Fiche technique

I. Introduction :

Dans le cadre de la consolidation des acquis de notre pays en matière de vaccination et en vue d'accélérer la progression vers l'atteinte des objectifs de lutte contre les maladies évitables par la vaccination à travers la mise en place de stratégies spécifiques, le Ministère de la Santé et de la protection sociale a introduit avec succès depuis 2017 dans le cadre de la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire, organisée chaque année à la rentrée scolaire, la vérification et le rattrapage vaccinal vis à vis de la Poliomyélite, la Diphtérie, le Tétanos et la Coqueluche, en plus de la rougeole et la rubéole pour faire bénéficier et protéger le maximum de la population cible à travers une vaccination complète réduisant ainsi, le nombre de cas susceptibles.

À cet égard, la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire constitue une occasion incontournable pour y intégrer la **vérification du statut vaccinal et le rattrapage** vaccinal des élèves de la 1^{ère} année du primaire, contre la Poliomyélite, la Diphtérie, le Tétanos et la Coqueluche, en plus de la rougeole et la rubéole.

II. Objectifs et modalités de vérification et de rattrapage :

Lors de la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire, les professionnels de santé **sont tenus de procéder de manière systématique à la vérification du statut vaccinal des élèves de la 1^{ère} année du primaire sur la base d'un document (carnet de santé de l'enfant, registre de vaccination...)** pour s'assurer qu'ils sont **complètement** vaccinés, et ce contre :

- La rougeole et la rubéole : par la prise de 2 doses de vaccin contre la rougeole





١٦ ١ ٢٠٢٣

D/2023/DP/SMI/PSI/PNI/167

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé
et de la Protection Sociale

Objet: Activités supplémentaires de vaccination des enfants de moins de 6 ans : Fiche technique.

Réf : Lettre de Monsieur le Ministre à Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de la Santé et de la Protection Sociale, DELM/DP N° 182124 du 30 octobre 2023.

Faisant suite à la lettre citée en objet, relative au renforcement des activités de vaccination et de la surveillance épidémiques et en vue de renforcer l'immunité de la population ciblée par le Programme National d'Immunisation, des activités supplémentaires de vaccination ont été mises en place concernant particulièrement la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole et la rubéole.

A cet effet, vous trouverez ci-joint une fiche technique comportant les informations nécessaires pour assurer le rattrapage vaccinal des enfants de moins de 6 ans et ce, en fonction de leurs âges et de leurs antécédents vaccinaux.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux, l'expression de mes meilleures salutations.

Le Directeur de la Population
Dr. YAHYANE Abduhakim



Direction de la Population

Programme National d'Immunisation

Rattrapage vaccinal des enfants âgés de moins de 6 ans

Recommandations 2023

Fiche technique

I. Introduction :

La vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus efficaces. Les efforts consentis depuis des décennies dans le cadre du Programme National d'Immunisation (PNI) ont permis la contribution à la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile. Cependant et afin de préserver ces acquis et éviter la résurgence des maladies potentiellement épidémiques et qui sont évitables par la vaccination ; il est essentiel de veiller au respect du Calendrier National de Vaccination et à maintenir une couverture vaccinale supérieure ou égale à 95% par antigène, par milieu et par niveau.

Ainsi et afin de regagner du terrain après le recul des couvertures vaccinales occasionné par la pandémie de COVID-19, il est primordial d'assurer le rattrapage vaccinal pour renforcer l'immunisation des enfants et améliorer les taux de couvertures vaccinales à travers la relance et le rattrapage vaccinal des enfants âgés de moins de 6 ans.

II. Le rattrapage vaccinal des enfants âgés de moins de 6 ans :

La vaccination de rattrapage est l'action de vacciner un individu qui, pour une raison quelconque n'a pas reçu/a manqué les doses de vaccins auxquelles il peut prétendre, conformément au Calendrier National de Vaccination.

Outil de collecte des données du rattrapage vaccinal



Programme National d'Immunisation

Suivi de la couverture vaccinale



وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
+٩٦٥ ٢٢ ٨ ١٠٤ ٨ ١٢٥ ٧ ١٠ ١٠
Ministère de la Santé et de la Protection sociale

Introduction

- Le suivi de la couverture vaccinale est un processus systématique et continu d'examen des données, des procédés et des pratiques spécifiques au programme de vaccination ;
- Il comporte :
 - l'observation permanente , la collecte continue et l'examen de données relatives aux réalisations vaccinales ;
 - la réalisation des ajustements nécessaires en cas d'écarts pour s'assurer que les progrès suivent les prévisions.
- Le suivi de la couverture vaccinale est une composante essentielle de la planification (il doit intégrer les plans d'action ou les micro-plans du PNI selon le niveau d'intervention);
- Il doit se faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres et tous les ans, il doit suivre les progrès au moins chaque mois.

Objectifs

- Mesurer les progrès sur la base des indicateurs de couverture vaccinale;
- Orienter les activités du programme de vaccination à tous les niveaux;
- Repérer les contraintes, les insuffisances et les domaines nécessitant des interventions particulières;
- Apporter des révisions et des corrections;

Utilisation de données locales pour atteindre :

« Un taux de couverture vaccinale d'au moins 95% [au niveau national, provincial et local (ESSP, Localité, secteur] et par antigène»

Suivi de la couverture vaccinale:
éléments à prendre en considération

I. Sources de l'information:

- Le cahier de santé de l'enfant ;
- le registre de vaccination ;
- les feuilles journalières de vaccination ;
- la fiche récapitulative mensuelle de la vaccination .

II . Indicateurs essentiels :

- Couverture par le vaccin **Penta.1** et par le **Penta.3** par ESSP et par province ;
- **Taux d'abandon** pour Penta1 à Penta3 ou Penta1 à RR1 ou RR1 à RR2 par ESSP et par province ;
- % des ESSP ayant enregistré des taux de couverture $\leq 95\%$ (surtout en Penta.3 et RR1) ;
- % des ESSP ayant enregistré des taux d'abandon $\geq 5\%$,

III. Outil essentiel de suivi de la couverture vaccinale:

- Graphique de suivi de la couverture vaccinale

100%																									
92%																									
83%																									
75%																									
67%																									
58%																									
50%																									
42%																									
33%																									
25%																									
17%																									
8%																									
0%																									
	Jan	Fév.	Total	Mars	Total	Avril	Total	Mai	Total	Juin	Total	Juil.	Total	Aout	Total	Sep	Total	Oct.	Total	Nov.	Total	Déc.	Total		
Penta1																									
Penta3																									
# AB																									
% AB																									

Population cible

% AB = $\frac{\text{Penta1} - \text{Penta3}}{\text{Pent1}}$ x 100

■ Graphique de suivi de la couverture vaccinale

- C'est un outil essentiel pour le suivi de la couverture vaccinale principalement au niveau local.
- Il montre les progrès réalisés eu égard à la couverture vaccinale de la population cible dans la zone de desserte de votre établissement de santé ;
- Il résume les informations qui figurent dans les rapports mensuels de vaccination.
- Il permet de comparer le nombre de personnes vacciné effectivement tous les mois avec les cibles de couverture.

■ Graphique de suivi de la couverture vaccinale

- Ce diagramme permet aux responsables des ESSP et au niveau des provinces, de voir si le programme est **en phase** avec les objectifs et cibles de couverture vaccinale et les taux d'abandon.
- Il doit être affiché sur le tableau de bord .
- Ce diagramme doit refléter les activités de vaccination offerte par l'ESSP (en stratégie fixe et mobile).

■ Comment renseigner le diagramme de suivi de la couverture vaccinale ?

1. Reporter les effectifs de la population cible annuelle et mensuelle ciblée par la vaccination

a) Population cible annuelle :

Servez-vous des données officielles fournies par le (SEIS) ou les estimations locales .

b) Cible mensuelle :

- Pour obtenir la population cible mensuelle, divisez le nombre de la population ciblée annuelle par 12.
- **Exp** : Si la cible annuelle est de 156, la cible mensuelle est de $156/12 = 13$;

2. Remplir le diagramme :

1. Remplir les renseignements figurant au sommet du diagramme, à savoir le lieu et l'année.
2. Inscrire sur le côté gauche du diagramme les chiffres ciblés mensuellement.
3. Remplir les cases du bas avec le nom des vaccins à suivre

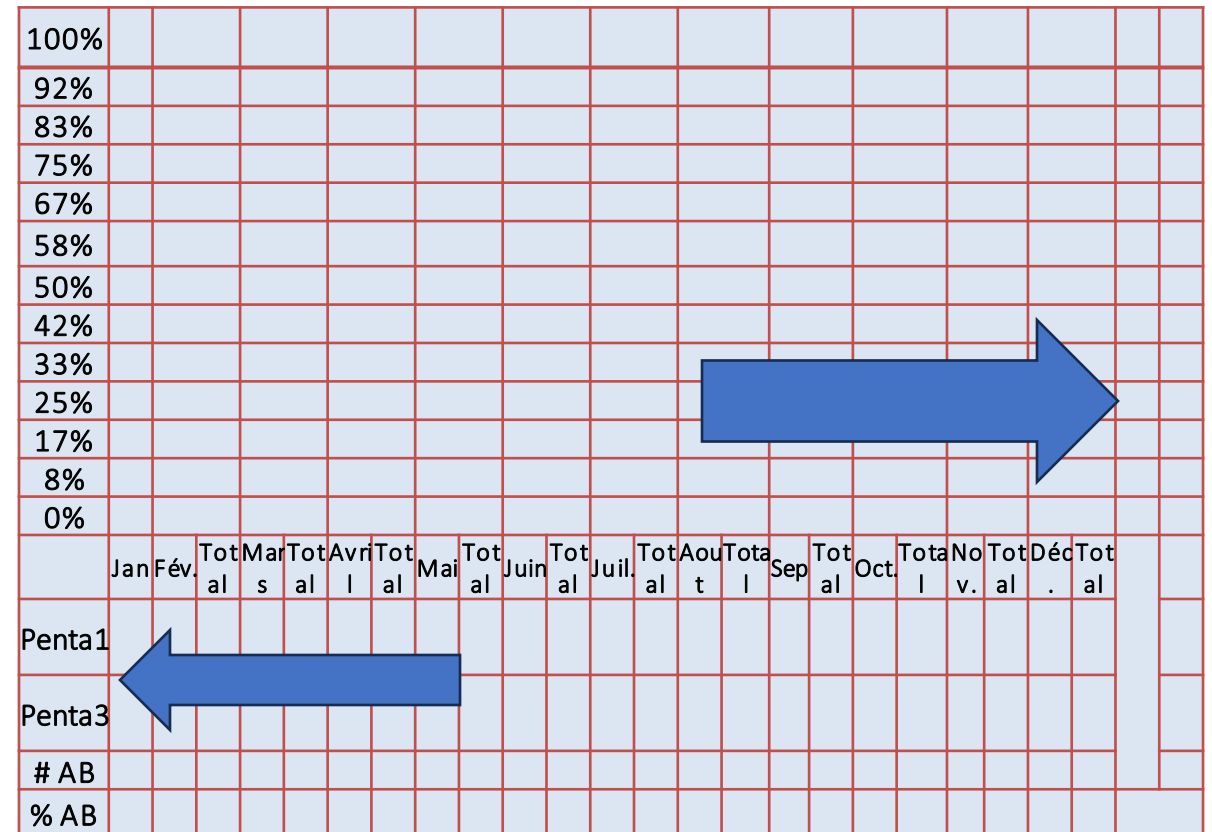
Exp: Penta1 et Penta3 ou
Penta1 et vaccin anti-
rougeoleux,.

Région :

Province :

Formation sanitaire :

Population cible annuelle (- 1 an)



3. Reporter les données de la vaccination dans le diagramme:

1.Reporter les données de la vaccination dans le diagramme.

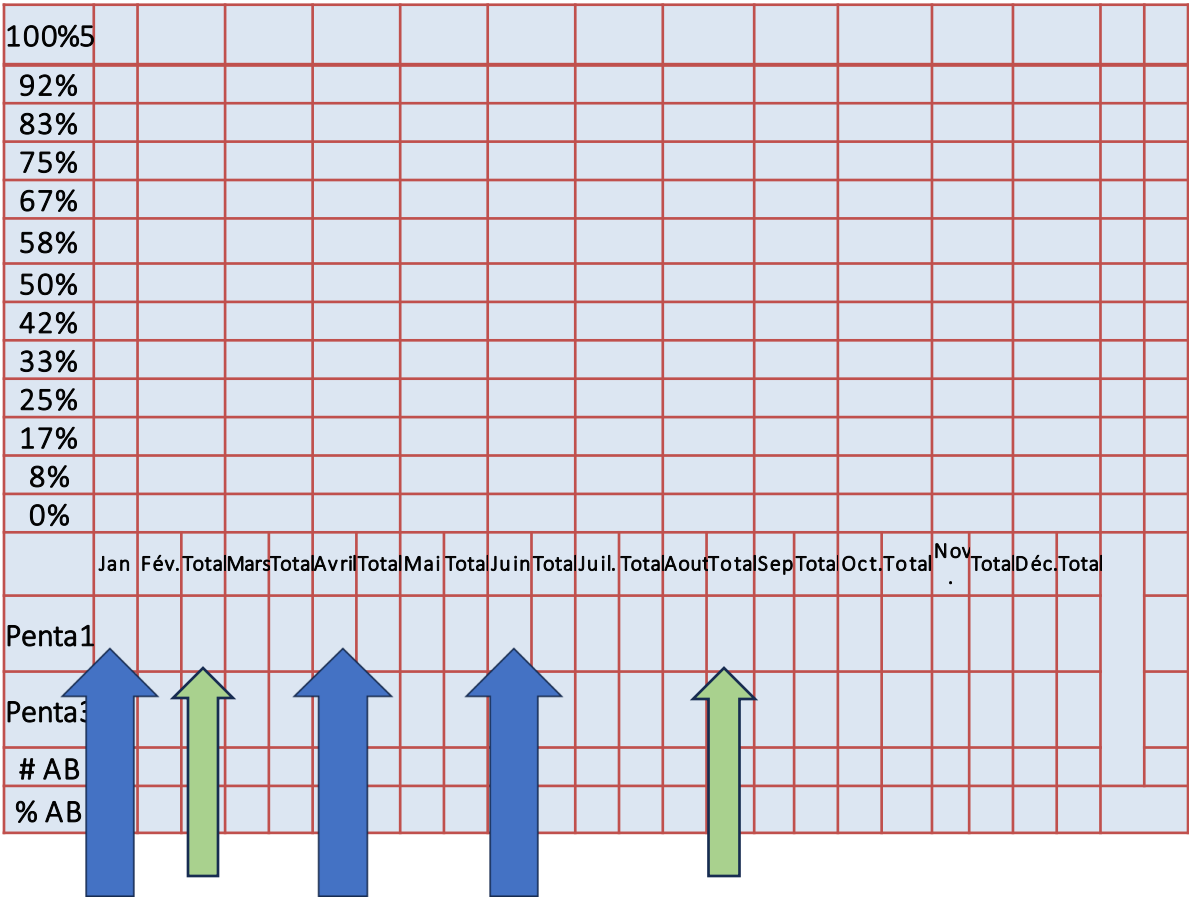
(L'exemple donné se sert de Penta1 et Penta3, mais d'autres taux peuvent être employés (p.ex. Penta1 et vaccin anti-rougeoleux))

2.Repérer les espaces réservés au mois que vous enregistrez. Inscrire le total mensuel des Penta1 administrés.

3. Ajouter le total du mois en cours au total cumulé précédent afin de calculer le total cumulé actuel et l'inscrire sur la partie droite de la colonne du mois que vous enregistrez.

Voir graph : Pour Penta 1

Prestations du mois de mars est 4,
le total cumulé (janvier et février est 11)
Alors , total cumulé en mars est 11+4= 15



3. Reporter les données de la vaccination dans le diagramme (suite):

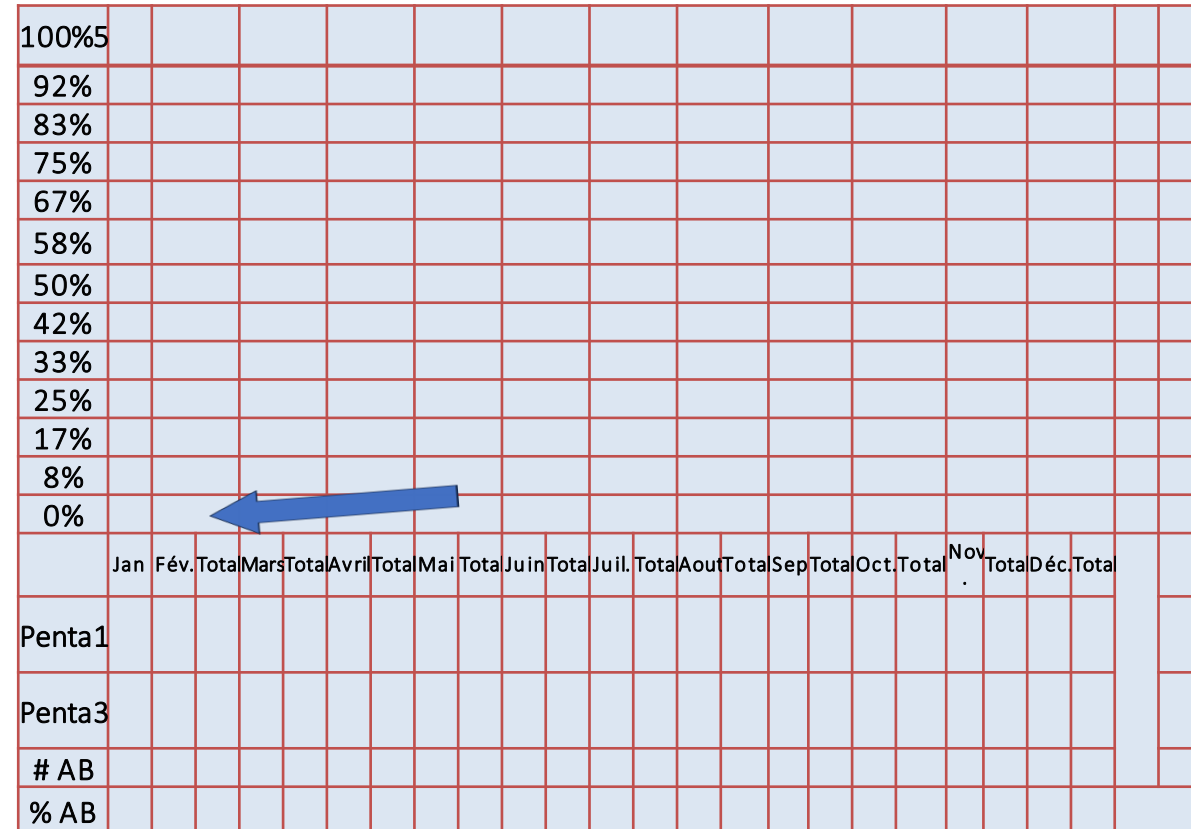
4. Sur le graphique, reporter le point correspondant au total cumulé total enregistré sur le côté droit de la colonne du mois qui vous intéresse.

5. Relier ce nouveau point au point du mois précédent par une ligne droite.

6. Répéter les étapes qui précèdent tous les mois jusqu'à la fin de l'année.

7. Reporter les Penta3 administrés de la même façon que les Penta1.

8. Calculer le nombre total d'abandons survenus entre le Penta1 et le Penta3 : Soustraire le total cumulé des Penta3 du total cumulé des Penta1

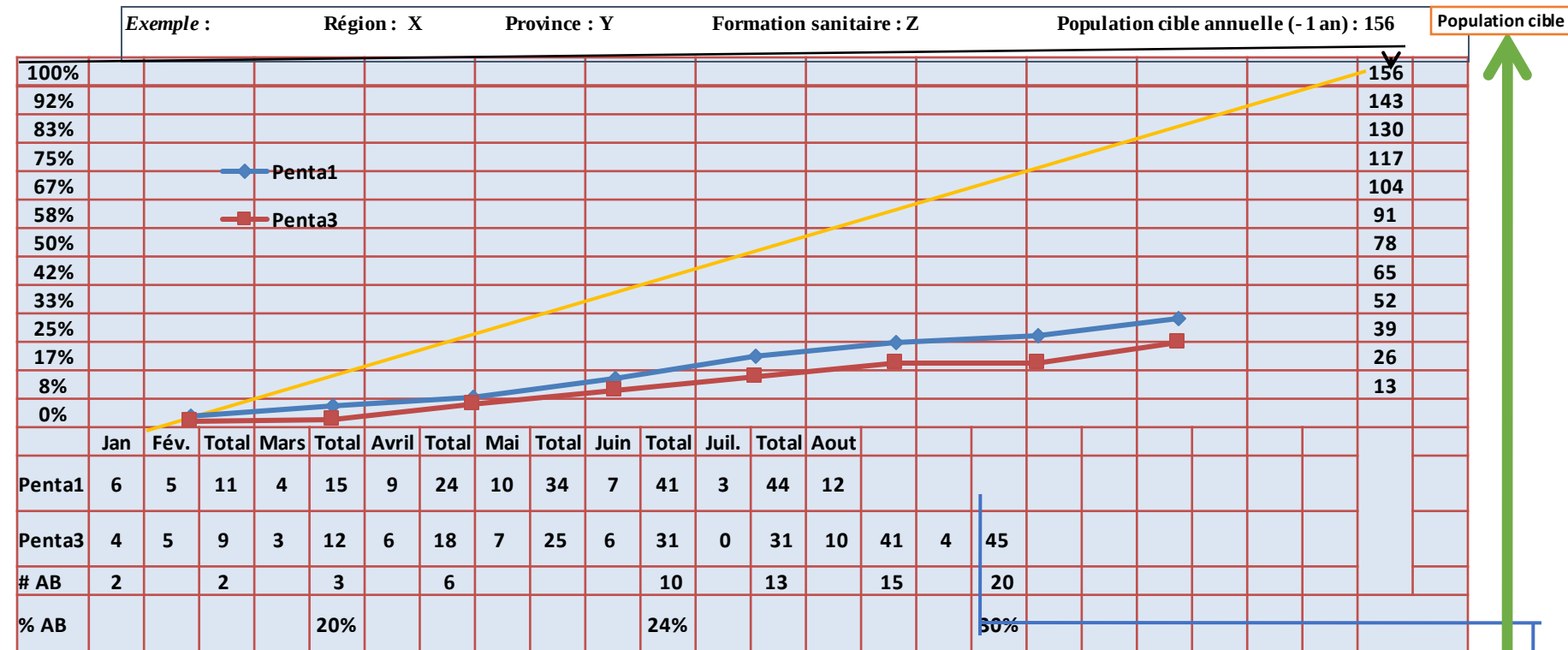


9. Calculer le taux d'abandon cumulé comme suit :

$$\left[\frac{\text{Total Penta1 cumulés} - \text{Total Penta3 cumulés}}{\text{Total Penta1 cumulés}} \right] \times 100$$

- Le taux d'abandon peut être suivi visuellement sans difficulté : c'est l'espace qui sépare la ligne du Penta1 de celle du Penta3.
- Il y a plusieurs façons de suivre la couverture et les abandons à l'aide de diagrammes, dont les principaux sont :
 - Penta1 et Penta3
 - Penta1 et RR1
 - BCG et RR1.

Le Diagramme de suivi de la couverture et des abandons



$$\% \text{ AB} = \frac{\text{Penta1} - \text{Penta3}}{\text{Pent1}} \times 100$$

ÉTAPE 1 : Évaluer la taille de la population cible :

ÉTAPE 2 : Indiquer les objectifs de couverture annuelle et mensuelle

ÉTAPE 3 : Consigner les doses mensuelles de vaccins

ÉTAPE 4 : Calculer les totaux cumulatifs et annuels et les taux d'abandon.

ÉTAPE 5 : Interpréter et exploiter l'information

4. Interprétation du digramme:

- Si la ligne de total cumulé représentant les vaccinations réelles effectuées par votre personnel est sur la ligne cible ou au-dessus d'elle, vous faites des progrès satisfaisants.
- Si elle est au-dessous mais près de la ligne cible, vos résultats sont modestes.
- Si votre ligne est largement en dessous de la ligne cible, vous ne progressez pas : Il faut trouver les raisons et prendre les mesures qui s'imposent en se posant les questions suivantes :
 - Les séances se tiennent-elles périodiquement, au bon moment, et dans un endroit facile d'accès) ?
 - Des occasions de vacciner les enfants sont-elles manquées ?
 - Discutez du problème avec votre superviseur et décidez de ce que vous pouvez faire pour améliorer le programme?

Concepts

Taux d'abandons

L'abandon est une comparaison entre :

- le nombre d'enfants qui commencent à recevoir les vaccinations; et
- ceux qui reçoivent les doses ultérieures

Taux d'abandon Penta1 – Penta3:

$$\frac{\text{Nbre cumulatif de doses Penta1} - \text{Nbre cumulatif de doses penta3}}{\text{Nbre cumulatif de doses Penta1}} \times 100$$

Taux d'abandon Penta1 – RR1:

$$\frac{\text{Nbre cumulatif de doses Penta1} - \text{Nbre cumulatif de doses de RR1}}{\text{Nbre cumulatif de doses Penta1}} \times 100$$

Raisons de l'abandon

- Manque d'information sur le calendrier vaccinal
- Qualité des services
- Occasions manquées
- Fausse contre-indications

Comment réduire les taux d'abandon ?

- Assurer une information adéquate
- Préparer des listes des enfants attendus
- Identifier et relancer les retardataires et les défaillants
“Rôle des registres”
- Améliorer la qualité des services
- Minimiser les occasions manquées
- Réduire les fausses contre-indications

Comment minimiser les occasions manquées ?

- Vérifier systématiquement le statut vaccinal de tout enfant et toute femme mariée en âge de procréer lors de tout contact avec le système de santé et rattraper immédiatement les défaillants
- Instructions/Formation du personnel de santé s'occupant de soins curatifs

Réduire les fausses contre-indications

- Vaccins = interventions médicales les plus sécurisantes
- Seule contre-indications = Maladies évolutives graves
- Besoins d'une politique nationale claire
- Besoins de former tout le personnel

Augmenter la couverture vaccinale de routine

1. Améliorer l'accès aux services de routine
 - Plus de centres fixes
 - Activités itinérantes soutenables
2. Améliorer l'utilisation des services existants
 - Réduire le taux d'abandon
 - Minimiser les occasions manquées de vaccination
 - Réduire les fausses contre-indications
3. Renforcer les activités de mobilisation sociale

Supervision Formative?

- Visites de supervision régulières
- Pas inspection!!!
- Combinées avec une formation “sur le lieu du travail”
- Focalisant sur des aspects spécifiques et prioritaires chaque année
- S’intéressant aux progrès (analyse des diagramme) et contraintes rencontrées dans les activités prioritaires
- Rectifiant les problèmes notés

Comment opérationnaliser la supervision formative?

- Assurer au moins 1 visite/mois pour chaque structure
- Allouer le temps qu'il faut pour :
 - Évaluer et détecter les faiblesses (Grille de supervision)
 - Améliorer/rafraichir les connaissances des PS
 - Vérifier l'état des stocks (vaccins, seringues, etc.)
- Conduire une session de formation si nécessaire et distribuer les documents de formation aux PS.

Supervision formative: Suggestions

- Aider les équipes du CS à finaliser leur plan de travail
- Bon usage du graphique de suivi de la couverture vaccinale
- Développer les cartes des population à desservir
- Estimation et commande des besoins en vaccins et en matériel d'injection
- Sécurité des injections
-

Merci pour votre attention